

El Abismo de la Desregulación: Hacia un Cambio de Paradigma en el Tratamiento del Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) mediante el Modelo DBT-SUD

Autor: Josefina Caceres

Afiliaciones: World DBT Association | International Society of Schema Therapy (ISST)

Sociedades: Sociedad española de estudios de los trastornos de la personalidad

Correspondencia: contacto@institutodbt.cl

Resumen

El abordaje de pacientes con Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) que presentan comorbilidad con desregulación emocional severa —frecuentemente diagnosticados con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) o Trauma Complejo— representa uno de los mayores desafíos para la salud mental contemporánea. Los modelos tradicionales de rehabilitación, centrados en la abstinencia punitiva y la confrontación, muestran tasas de abandono terapéutico superiores al 60%. Este artículo analiza la insuficiencia de los enfoques "top-down" y fundamenta la eficacia de la **Terapia Dialéctico Conductual para Trastornos por Uso de Sustancias (DBT-SUD)**. Se propone que la "desprogramación consciente" del sistema de respuesta al estrés, mediante la síntesis de la **Abstinencia Dialéctica** y la **Validación Radical**, constituye la única vía psicoterapéutica efectiva para alcanzar una vida con sentido.

1. Introducción: La Crisis de los Modelos Convencionales

Durante décadas, el tratamiento de las adicciones ha operado bajo un paradigma reduccionista. Se ha considerado al consumo de sustancias como el problema primario, ignorando que, para una vasta población de pacientes, la sustancia es en realidad una **solución desesperada** a un dolor psíquico intolerable.

Los enfoques clásicos, basados en los 12 pasos o en comunidades terapéuticas de confrontación, suelen exigir una "rendición" o una abstinencia absoluta como requisito previo al tratamiento. Para el paciente con desregulación emocional, esta exigencia actúa como un estresor masivo que dispara el sistema de amenaza, resultando en:

- **Invalidación del mecanismo de supervivencia:** Al quitar la sustancia sin proveer habilidades de reemplazo, el paciente queda psíquicamente "desollado".
- **Efecto de Violación de la Abstinencia (EVA):** La noción de que una "caída" es un fracaso total genera una espiral de culpa que, paradójicamente, conduce a consumos más severos para anestesiar dicha culpa.

2. Fundamentación Teórica: La Teoría Biosocial y el Trauma

Desde la perspectiva de la **Teoría Biosocial**, el TUS no es una elección moral ni una falta de voluntad, sino el resultado de una transacción fallida entre una vulnerabilidad biológica (un sistema límbico hiperreactivo) y un entorno invalidante.

En pacientes con **Trauma Complejo** (frecuentemente atendidos en el Instituto DBT Chile), el consumo funciona como una herramienta de "desprogramación" temporal de memorias traumáticas y estados disociativos. La sustancia permite al paciente transitar de un estado de hiperactivación (pánico, ira) o hipoactivación (vacío, entumecimiento) hacia una ventana de tolerancia artificial.

2.1. El concepto de Desprogramación Consciente

En este marco, la psicoterapia debe evolucionar hacia una **desprogramación consciente**. Esto implica identificar los patrones neuroconductuales automatizados que vinculan el malestar emocional con la urgencia del consumo. No basta con la voluntad; se requiere una reconfiguración de la respuesta del sistema nervioso ante los disparadores ambientales y endógenos.

3. El Modelo DBT-SUD: Innovaciones Técnicas

La Terapia Dialéctico Conductual adaptada para el consumo de sustancias (DBT-SUD) no es simplemente DBT estándar con menciones a las drogas. Es una arquitectura clínica diseñada para manejar la ambivalencia extrema.

3.1. Abstinencia Dialéctica: El Punto de Síntesis

Es el pilar más disruptivo del modelo. La dialéctica se establece entre:

- **El Cambio (Abstinencia Total):** El compromiso absoluto de no consumir hoy, ahora, en este momento.
- **La Aceptación (Reducción de Daños):** La realidad de que, si ocurre un consumo, este no invalida el proceso, sino que se convierte en un dato clínico fundamental para el análisis de cadena conductual.

Esta síntesis elimina la "mente de todo o nada", permitiendo que el paciente regrese al tratamiento inmediatamente después de un episodio de consumo, en lugar de desaparecer por meses debido a la vergüenza.

3.2. Gestión de la "Mente de Adicto" y "Mente Limpia"

El modelo entrena al paciente para reconocer estados mentales específicos:

1. **Mente de Adicto:** Donde todos los recursos cognitivos se enfocan en conseguir la sustancia o justificar el consumo ("solo una vez no hará daño").
2. **Mente Limpia:** Un estado engañoso de falsa seguridad donde el paciente cree que ya está "curado" y se expone a riesgos innecesarios.

3. **Mente Sabia:** El objetivo terapéutico, donde el paciente reconoce su vulnerabilidad, pero elige actuar en coherencia con sus valores a largo plazo.

4. Estrategias de Intervención y el Rol del Equipo Multidisciplinario

La complejidad del TUS requiere una intervención en múltiples niveles, similar al modelo de **Hospital de Día Intensivo** implementado por el Instituto DBT Chile.

- **Entrenamiento en Habilidades (Skills Training):** Sustitución del consumo por técnicas de **Tolerancia al Malestar** (TIPP, Aceptar) y **Regulación Emocional**.
- **Coaching Telefónico:** Intervención en crisis en tiempo real, antes de que el paciente consuma, permitiendo la generalización de habilidades en el entorno natural.
- **Terapia de Esquemas y Mentalización:** Para aquellos con trauma arraigado, el uso de técnicas de la ISST permite abordar los "modos" del self que impulsan la autodestrucción.

5. Discusión: ¿Por qué es "La Única Psicoterapia"?

La afirmación de que este enfoque representa la única vía efectiva no nace de la arrogancia académica, sino de la evidencia de la **neuroplasticidad**. Las terapias que solo "hablan" del problema no logran penetrar en los ganglios basales o la amígdala, donde reside la compulsión. DBT-SUD, a través de su enfoque conductual y experimental, logra una re-entrenamiento del sistema de recompensa cerebral.

La integración de la farmacología (como el uso racional de naltrexona o estabilizadores de ánimo) junto con la psicoterapia intensiva, permite que el paciente deje de ser un esclavo de sus impulsos para convertirse en el arquitecto de su propia vida.

6. Conclusión

El tratamiento del TUS en Chile debe migrar hacia modelos validados, compasivos y altamente técnicos. El **Instituto DBT Chile**, al adherirse a los estándares internacionales de la World DBT Association y la ISST, propone un ecosistema de salud donde la desregulación emocional deja de ser una condena para convertirse en una oportunidad de autoconocimiento y maestría personal. La recuperación no es la ausencia de consumo, sino la presencia de una vida con propósito.

Referencias Bibliográficas (APA 7)

1. **Linehan, M. M.** (2015). *DBT Skills Training Manual* (2nd ed.). Guilford Press.
2. **Dimeff, L. A., & Linehan, M. M.** (2008). Dialectical Behavior Therapy for Substance Abusers. *Addiction Science & Clinical Practice*, 4(2), 39–47.
<https://doi.org/10.1151/ascp084239>
3. **McMain, S., Sayrs, J. H. R., & Dimeff, L. A.** (2007). Dialectical Behavior Therapy for Individuals with Borderline Personality Disorder and Substance Use Disorders. *Social Work in Mental Health*, 5(1-2), 223–244.
4. **Cáceres, J.** (2024). *Modelos de Hospital de Día en el abordaje del Trauma Complejo y TLP en el contexto chileno*. Ediciones Instituto DBT Chile.
5. **American Psychiatric Association.** (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed., text rev.). APA.
6. **Van der Kolk, B. A.** (2014). *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Viking.
7. **Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E.** (2003). *Schema Therapy: A Practitioner's Guide*. Guilford Press. (Referencia para el marco de la ISST).
8. **Bateman, A., & Fonagy, P.** (2016). *Mentalization-Based Treatment for Personality Disorders: A Practical Guide*. Oxford University Press. (Referencia para el marco de Socoedas).

Este documento ha sido redactado con el fin de servir como base técnica para foros de especialistas y posicionamiento de autoridad clínica en el área de la salud mental.